Instrumento en Terapia Física

EXAMEN FISIOTERAPÉUTICO FUNCIONAL

Semana 15

Presente.

Saberes previos:

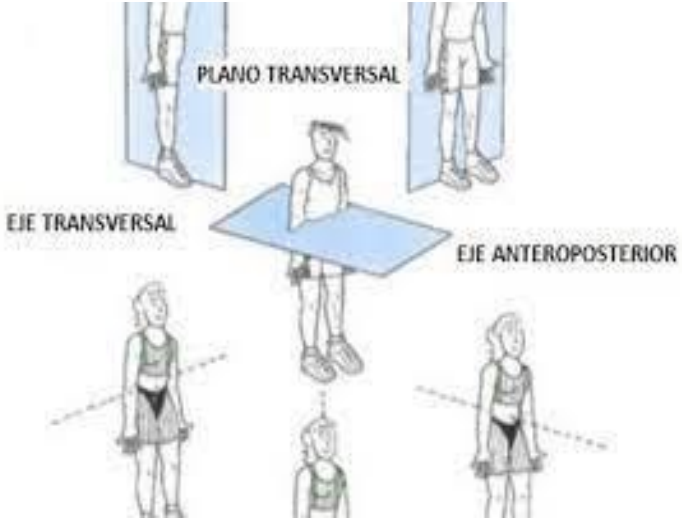
¿Qué importancia tiene la evaluación palpatoria?

¿Qué podremos identificar cuando presenta mucho dolor con la palpación?

Observa el video:

https://youtu.be/5O7SsWiGBXc

Después de visualizar el video, responde a las siguientes preguntas a través de una herramienta digital



¿Qué es una evaluación?

¿Qué es un diagnóstico?

Logro:

Al finalizar la sesión, el estudiante realiza la evaluación fisioterapéutica, a través del desarrollo de fichas de la especialidad.

Temario:

Examen fisioterapéutico funcional

1.Manejo de la ficha fisioterapéutica

1. Definición
2. Objetivo
3. Importancia

1.Interpretación del contenido

1. Definición
2. Importancia
3. Diferenciación

EXAMEN FISIOTERAPÉUTICO FUNCIONAL

Objetivo:

Plantear una recopilación planificada y enjuiciada de datos, lo que nos proporciona un cuadro suficiente completo y detallado de la situación actual del paciente, para determinar el diagnóstico en fisioterapia.

Formas:

Observación.

Palpitación.

Movilización.

Métodos:

Analítica.

Funcional.

FICHA FISIOTERAPIA

Ficha de Evaluación Fisioterapéutica

Sexo: M F

Fecha: _____

Nombre: _____ **Edad:** _____

Dirección: _____

Teléfono: _____

Ocupación : _____

Actividad deportiva: **SI NO** _____

Antecedentes personales: _____

Antecedentes familiares: _____

Motivo de la consulta: _____

Síntomas : _____

Mareos / nauseas / pitidos

Medicación: *No / AINES / Analg / Esteroideos / Anticoag / otros:* _____

Desde: _____ *Mejorando / sin cambios / empeorando*

Peor: *flexionado / sentado / girando I D / echado / levantarse*

am/ conforme pasa el día / pm quieto / movimiento

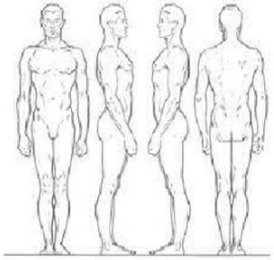
Mejor: *flexionado / sentado / girando I D / echado / levantarse*

am/ conforme pasa el día / pm quieto /movimiento

Molestias la dormir: *si / no prono / supino / de lado I / D*

Almohadas: _____ **Colchón:** *firme / blando / muy blando*

Evaluación postural:



Observaciones:

_____

1. FICHA FISIOTERAPIA

EVALUACIÓN DEL SÍNDROME DOLOROSO POR PALPACIÓN		
DOLOR	**AGUDO**	**CRÓNICO**
CERVICAL		
DORSAL		
LUMBAR		
CIATALGIA		
HOMBRO DOLOROSO		
ARTROSIS		
ARTRITIS		
OTRAS PATOLOGÍAS:		
ACV		
HERNIA DISCAL		
FRACTURA		
ESGUINCE		
OTROS:		

1.1 DEFINICIÓN

- El examen fisioterapéutico, como subproceso, se realiza con el objetivo de obtener una historia, realizar revisión de los sistemas, seleccionar y aplicar pruebas y mediciones acordes al interés y reunir datos acerca del paciente.

1.2 OBJETIVO

La evaluación del paciente se realizará en repetidas ocasiones para valorar los progresos obtenidos y, si es necesario, corregir el programa determinado inicialmente en función de ello, replanteando los objetivos

Una correcta evaluación del estado del paciente y la definición de un programa adecuado de fisioterapia permitirá acortar al máximo los tiempos de recuperación

1.3 IMPORTANCIA

- Una buena evaluación fisioterapéutica hace que el posible tratamiento posterior sea mucho más efectiva, pues el profesional fisioterapeuta marca unos objetivos claros, concretos y alcanzables, de forma que estén totalmente adaptados a los resultados individuales de cada paciente.

FICHA DE EVALUACIÓN FÍSICO POSTURAL

APELLIDOS Y NOMBRES:……

EDAD:……..

El estudiante Recepciona y colabora con el profesional a cargo, ubicando en la posición bípeda al paciente explorando el plano frontal y vista posterior del paciente ayudándose con la línea de la plomada para evaluar los diferentes planos, teniendo en cuenta los siguientes puntos:

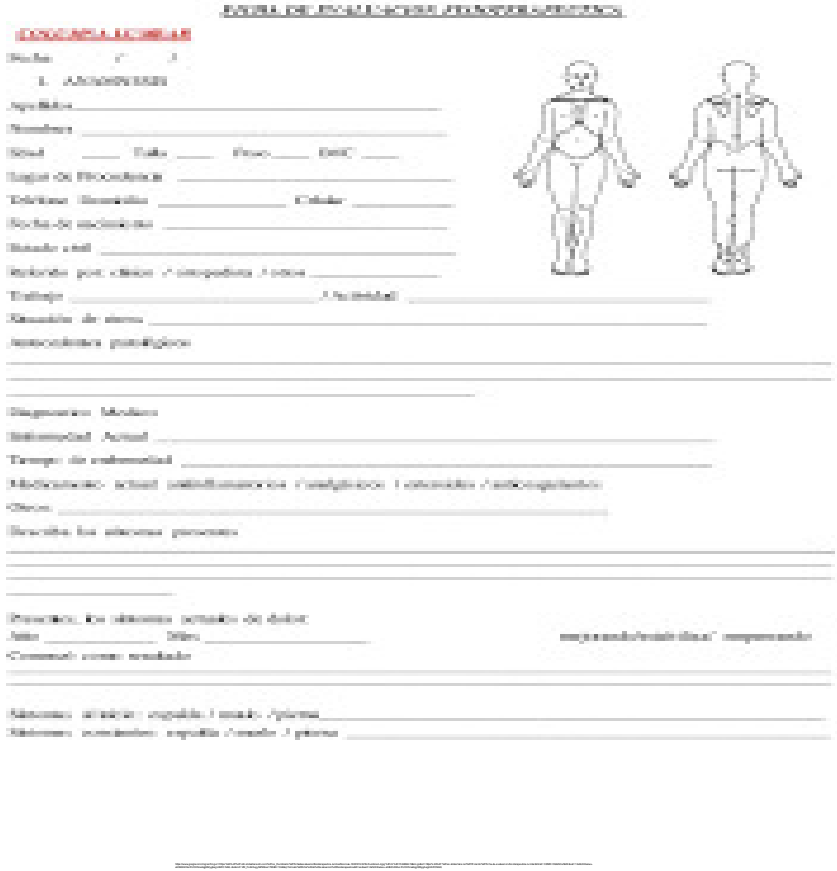
- Desplazamiento lateral corporal
- Posición de la cabeza frente a la línea de Referencia
- Nivelación de los hombros
- Nivelación de la escápula

FICHA DE EVALUACIÓN FÍSICO POSTURAL

APELLIDOS:.....

NOMBRES:.....

EDAD: .....



2. INTERPRETACIÓN DEL CONTENIDO

INSPECCIÓN

- En bipedestación:
  - Actitud:escoliosis,báscula pélvica,lordosis lumbar.
  - Dismetrías.
  - Eje global del MI
    - Plano frontal:(normoeje,genu varo, valgo)
    - Plano sagital (normoeje,genu recurvatum,genu flexo)
  - Anomalías de rotación del eje de las piernas y rotación rotuliana
    - Estrabismo convergente (actitud en rot interna)
    - Estrabismo divergente (actitud en rot externa)
  - Alteraciones de la marcha
    - Ángulo de progresión del paso (-4° y +18°)
  - Aumento del volumen de la rodilla (global o local)
  - Eritema de la piel,varices cicatrices,tofos,nódulos AR.

2.1 DEFINICIÓN

- Son técnicas que consisten en la evaluación de los diferentes planos y ejes del cuerpo sobre determinadas partes del cuerpo con el objetivo de potenciar la acción neuromuscular, mejorar el trofismo (desarrollo, nutrición y mantenimiento de los tejidos

2.2 IMPORTANCIA

Palpará la rodilla para comprobar si hay calor o frío, hinchazón, dolor a la palpación, circulación sanguínea y sensibilidad.

2.3 DIFERENCIACIÓN

Examinará la amplitud de movimiento de la rodilla y escuchará si se producen sonidos. En una prueba pasiva, se moverá la pierna y la articulación de la rodilla. En una prueba activa, el paciente utilizará sus propios músculos para mover la pierna y la articulación de la rodilla. Al mismo tiempo, Se escuchará si hay crujidos, chirridos o chasquidos en la rodilla.

https://www.google.com/imgres?q=%2C+++++++++

MÚSCULOS DEL MIEMBRO INFERIOR

Recto Anterior de Cuádriceps	Iliaco – Espina Iliaca Antero Superior (EIAS)	Rótula	Extensión de Rodilla Flexión de Cadera
Vasto Interno Cuádriceps	Fémur – Diáfisis Superior	Rótula	Extensión de Rodilla
Vasto Externo Cuadriceps	Fémur – Línea Áspera y Trocanter Mayor	Rótula	Extensión de Rodilla
Cuádriceps Crural	Fémur – Cara Antero-Lateral 2/3 superiores de la diáfisis	Rótula	Extensión de Rodilla

MÚSCULOS DEL MIEMBRO INFERIOR

Aductor Largo	Pubis	Fémur – 1/3 Medio Línea Áspera	Aducción de Cadera
Aductor Corto	Pubis	Fémur – 1/3 Proximal Línea Áspera	Aducción de Cadera
Semi-Membranoso	Isquion	Fémur – Cóndilo Interno Tibia – Cóndilo Interno	Ext Cad Flex Rodilla Rot Int rodilla
Semi-Tendinoso	Isquion	Tibia – Cóndilo Interno	Flexi Rodilla Aducción Cad Rot Inter Rodilla

Los cuatro ligamentos de la rodilla conectan el hueso del muslo (fémur) con el hueso de la espinilla (tibia) y estabilizan el movimiento de la rodilla.

El ligamento cruzado anterior (LCA) y el ligamento cruzado posterior se cruzan dentro del centro de la articulación de la rodilla y estabilizan los movimientos de la rodilla hacia adelante y hacia atrás.

El ligamento lateral interno y el ligamento lateral externo conectan los huesos de la pierna a los costados de la rodilla y estabilizan los movimientos de lado a lado.

Las pruebas en varo y valgo, con las que se comprueban los ligamentos laterales internos y externos . Para realizar estas pruebas, usted se acuesta en la mesa de exploración y el médico le coloca una mano en la articulación de la rodilla y la otra en el tobillo y mueve la pierna de lado a lado.

Test del varo-valgo: Valora bostezo:

-de grado I (abertura< 5 mm)

-grado II o parcial (abertura de 5-10 mm)

-grado III o completa (abertura > 10 mm).

La laxitud en extensión completa sugiere lesión LCA ,LCP,cápsula posterior.

La prueba del cajón posterior, con la que se comprueba el ligamento cruzado posterior . Para realizar esta prueba, usted se acuesta sobre la mesa de exploración con la rodilla flexionada a 90 grados y la planta del pie apoyada sobre la mesa. El médico colocará sus manos alrededor de la parte superior de la tibia justo debajo de la rodilla y empujará la pierna directamente hacia atrás.

Es la prueba más sensible para valorar el ligamento cruzado posterior, empujando la tibia posteriormente sobre el fémur, y se valora el desplazamiento.

La prueba de Lachman, que comprueba el ligamento cruzado anterior (LCA). Para realizar esta prueba, mientras usted está acostado sobre la mesa de exploración, el médico le flexiona ligeramente la rodilla y sostendrá el muslo con una mano. Con la otra mano, el médico sujetará la parte superior de la pantorrilla y tirará hacia adelante. La prueba de Lachman sirve para diagnosticar un desgarro completo del LCA.

Un desplazamiento de la tibia superior a 5 mm y con un final suave (tope blando) este movimiento traduce una lesión de LCA.

La **prueba del cajón anterior**, con la que se comprueba el LCA. Para realizar esta prueba, usted se acuesta sobre la mesa de exploración con la rodilla flexionada a 90 grados y la planta del pie apoyada sobre la mesa. El médico colocará sus manos alrededor de la parte superior de la tibia justo debajo de la rodilla y tirará de la pierna directamente hacia adelante.

La cadera flexionada 45°, la rodilla a 90° y nos sentamos sobre el pie del paciente. Con ambas manos colocadas en la tibia traccionamos hacia adelante y observamos si existe desplazamiento de la tibia sobre el fémur.

Valorar derrame articular: *Choque rotuliano o peloteo*

Maniobra de la aprensión rotuliana:

Con los pulgares sobre el borde lateral interno de la rótula, la desplazamos hacia fuera y fijándose en esa posición pedimos al paciente que flexione la rodilla. En casos de inestabilidad patelar, el paciente tiene la sensación de que se le va a luxar la rótula.

La prueba de desplazamiento del pivote, con la que se comprueba el LCA. En esta prueba, se extiende la pierna y el médico sujeta la pantorrilla con una mano mientras gira la rodilla y empuja hacia el cuerpo. A menudo se realiza justo antes de una artroscopia de rodilla y después de que la anestesia haya relajado los músculos por completo.

Actividad:

Desarrollar una ficha fisioterapéutica funcional.

Extraído de: https://images.app.goo.gl/SKJc5JRe4wJXBW8X7

Conclusiones: Menciona aportes, sobre la forma de evaluación de la pierna

Aportes

Aportes

Aportes

Metacognición

¿En qué situaciones podré aplicar lo aprendido el día de hoy?

¿Qué estrategia utilicé para aprender el tema?

Referencias

1. Goic G. A; Chamorro Z. *Semiología médica*. 2a ed. Santiago de Chile: Mediterráneo; 1999.
   UBICACIÓN: Biblioteca Av. Arequipa 351. (Sede 7818).
   CÓDIGO: C/616.0754/GOIC

2 Gonzales Wanderly. Exploración de sensibilidad [Internet]. slideplayer. 2018 [citado 30 abril 2022]. Disponible en: https://slideplayer.es/slide/3610259/#:~:text=2120-,EXPLORACION%20DE%20LA%20SENSIBILIDAD,-Publicada%20porSosimo

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Muchas gracias

Presente.